جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : دلال محمد السيد رزق
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الشرابيه **العنوان :** -------
رقم البطاقة : 26810040104267 **رقم التليفون :** 01282452077 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 10-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 04-10-1968 **المهنة :** حاصل علي دبلوم

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: دلال محمد السيد رزق
National ID: 26810040104267

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

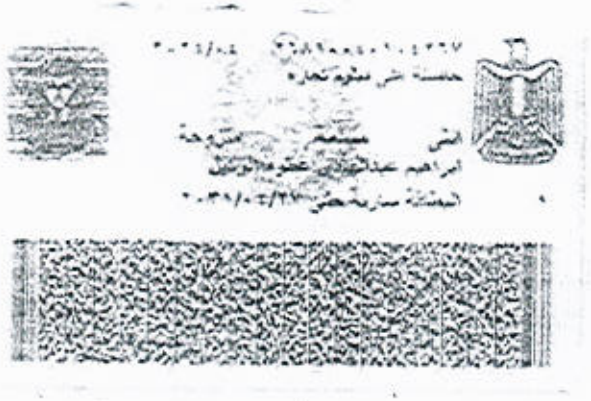
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

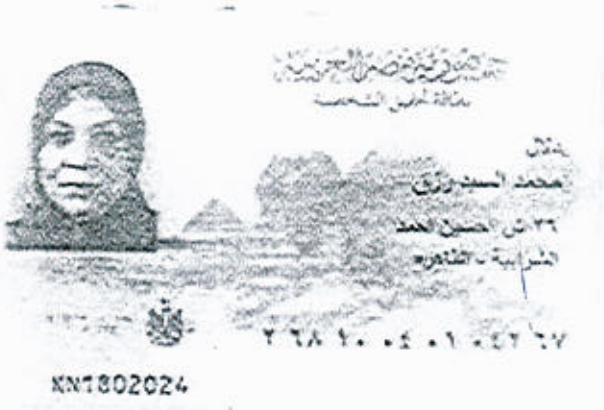
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





KN1802024

٢٧٦٢٢٠١٠٤-٢٦٨١-٢

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	:	Request No.	: 137354
Patient No.	: 26810040104267	Request Date	: 18/11/2021
Path No	: 2818/21	Verification Date	: 21/11/2021
Sex	: Female	Financial Category	:
Age	: 53 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Breast mass

Nature of the specimen: Biopsy
Gross Examination: Seven grayish white and hemorrhagic tissue cores, up to 1.2 cm long
Totally submitted.
- Procedure: Tru cut
- Localization: Left

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade : G II
- Angioinvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: No

Diagnosis:
Left breast mass, Core biopsy.
- Invasive duct carcinoma, grade II
- Biomarkers: PENDING
  - o ER: Intensity --% nuclear reaction (Allred score --/8)
  - o PR: Intensity --% nuclear reaction (Allred score --/8)
  - o Her2: Intensity --% membrane reaction (score --)
  - o Ki67: % nuclear reaction

Prof.Dr. Gamal AbdEl Aty
Dr.Mona Mohamed

Verified by :
mona mohamed

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: دلال محمد السيد	
MR. : 4576	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

58 Y OLD FEMALE PATIENT DIAGNOSED AS LT BREAST CANCER 2022 IDC GRADE 2 TRIPLE POSITIVE NACT THEN LT BCS PT1N1MO PORTH , ADJ KADCYLA FOR 1 YEAR THEN HT AI SINCE 11/2022 TILL NOW FOR AI FOR 3 MONTH

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	
الطبيب المعالج :	nada mohamed elsayed		

يعتمد ,

Patient Name	:	Request No	: 13008421
Patient No	: 26810040104267	Request Date	: 05/10/2022
Path No	: 2974/22	Verification Date	: 30/10/2022
Sex	: Female	Financial Category	:
Age	: 53 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

- Resection Margins Free all reescted margins
- Histologic responce to therapy Pathologic partial responce

Diagnosis:
Left breast cancer , WLE &ALND specimens
-Invasive duct carcinoma , grade II
-Free all reescted margins
-Lymph nodes: (3/16)
-Pathologic partial responce
-Stage ypT 1b , ypN1
-RCB 3 569 , class III

Prof Gamal Abdelatty
Dr Esraa magdy

Verified by :
dr.esraa magdy

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name : Dalal Mohamed Elsayed. Date : 22/12/2021

POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED:

A case with history of newly discovered breast cancer.

1. *Chest:*
   - A soft tissue [illegible] in the left breast [illegible] in the lower outer quadrant.
   - No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
   - No hilar or mediastinal lymph nodes.
   - No evidence of pleural effusion or masses.
   - Cardiomegaly with left ventricular configuration.
   - No pericardial circular detected.
2. *Abdomen and pelvis:*
   - The liver is of average size with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
   - Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries. No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
   - Few gall bladder stones are seen with largest measuring about 3 2cm.
   - The spleen is of average size with no focal lesions seen.
   - Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys, with no stones or any pressure changes.
   - Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
   - Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
   - No pelvi-abdominal collections.
   - Few bilateral prominent inguinal lymph nodes.
   - No lytic or sclerotic bone lesions.
   - L4-5 Grade II lytic spondylolithesis with fracture pars interarticularis and internal fixation.

OPINION:

- *A case with history of newly discovered breast cancer showing no evidence of distant neoplastic lesions.*
- *Cardiomegaly.*
- *Fatty liver, gall bladder stones.*
- *L4-5 Grade II lytic spondylolithesis with internal fixation.*

Much Obliged,
Dr. Sherif Sequeh, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

MDT FORM 15 / 11 / 20 6

Name		MRN	
		ID	
Age		Phone	
Menopausal status		Marital status	
NRS SCORE		Family history	
BMI		REASON OF MDT	
CO morbidity			

Clinical Data

BX:

ER: 8/8	PR: 8/8	HER 2: -ve	KI67: 15 ? o%

Sonomammography:

Mets Workup:

LN (BIRADS

CT-CAP Free

R L



TNM

MDT OUTCOME & PLAN

TDM, 16 cycles / PORT / A.I 7 yrs

SIGNATURE					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

[[DOCTYPE:CT SCAN]]
CT Scan

Patient's Name:	Dalaal Mc d Rizq
Date:	2026-08-06
Referred by:	Prof.Dr. no doctor
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

MULTISLICE NON CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest with multiplanar reconstruction. No IV contrast was used.

FINDINGS:

- Left upper lobar and lingual subplerual reticulations likely post therapeutic sequel
- Right upper lobar apical tiny pulmonary nodule measuring about 2mm
- no consolidation or cavitation.
- No pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No plural or pericardial collection.
- CT signs are suggestive of cardiomegaly
- Upper abdominal cuts show gall bladder stones

Opinion:-

- Left upper lobar and lingual subplerual reticulations likely post therapeutic sequel
- Right upper lobar apical tiny pulmonary nodule for follow up.
- Mild cardiomegaly.

Dr.Nourhan Ewis

Dr.Nourhan Ewis